



**VIS PHARMA
COMPASS**

governance for hospital pharmacy spend

Descrizione del prodotto

Governance della spesa farmaceutica

per Aziende Sanitarie e Regioni

Che cos'è	Strumento di analisi gestionale in sola lettura per la Direzione di Farmacia, la Direzione Sanitaria e il Servizio Farmaceutico Regionale.
Che cosa non è	Non è un dispositivo medico. Non interviene su decisioni relative al singolo paziente. Non sostituisce il gestionale di farmacia né la cartella clinica.
Stato	Prototipo funzionante su dati reali di quattro Aziende Sanitarie, 261.153 record di erogazione, 452,7 milioni di euro di spesa annua.
Destinatari	Direzione Generale, Direzione Sanitaria, Direzione di Farmacia, Controllo di gestione, Servizio Farmaceutico Regionale.
Documento	Versione [n], [gg/mm/aaaa]. Riferimento VPC-[anno]-[nnn].

Documento riservato. Contiene elementi di offerta economica e metodologica.
La denominazione commerciale è soggetta a verifica di disponibilità del marchio presso UIBM ed EUIPO, classi 9 e 42.

Indice

1	Perché nasce	1
1.1	Che cosa esiste oggi	1
1.2	Il divario che ne deriva	1
2	I bisogni, per soggetto	1
3	Che cosa fa e che cosa non fa	3
3.1	Qualificazione regolatoria	3
3.2	Coerenza con la legge 132/2025	3
4	Come funziona: l'architettura in cinque stadi	4
4.1	Le fonti in ingresso	4
4.2	Che cosa fa, in concreto, lo stadio 4	5
4.3	Scalabilità multi Regione	5
5	I moduli	5
5.1	Funzioni trasversali e di dettaglio	7
5.2	Limiti invalicabili, per modulo	8
6	Due livelli di titolarità: Azienda e Regione	8
6.1	Perché il confronto fra Aziende è la funzione decisiva	9
7	A chi si rivolge	9
7.1	Posizionamento rispetto ai sistemi esistenti	10
7.2	Indipendenza dai produttori	10
8	Evidenze dal prototipo su dati reali	10
8.1	Concentrazione della spesa	10
8.2	Esposizione alle scadenze brevettuali e quota residua su originator	11
9	Modello economico e costi	11
9.1	Il principio di attribuzione	11
9.2	Stima del valore su perimetro regionale	11
9.3	Listino modulare	14
9.4	Passo zero: analisi diagnostica	14
9.5	Configurazioni tipiche e percorso amministrativo	15
9.6	Rapporto fra valore e costo	15
9.7	Perché non si propone il risparmio condiviso	16
10	Dati, sicurezza e attivazione	16
10.1	Percorso di attivazione in novanta giorni	16
11	Limiti, assunzioni e condizioni di successo	17
11.1	Limiti dello strumento	17
11.2	Assunzioni della stima economica	17
11.3	Punti di diligenza tecnica ancora aperti	18
11.4	Condizioni di successo	18
12	Il percorso realistico di adozione	18
12.1	Prossimi passi	19

1 Perché nasce

La spesa per i farmaci acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche italiane ha raggiunto circa 17,8 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 10% sull'anno precedente. Nei primi dieci mesi del 2025 la spesa per acquisti diretti si è collocata al 12,06% del Fondo Sanitario Nazionale contro un tetto programmato dell'8,3%, con uno sforamento di 4.243,9 milioni di euro.

Il problema non è la mancanza di dati. Le Aziende Sanitarie dispongono già dei flussi di consumo ospedaliero, di distribuzione diretta, di distribuzione per conto e di File F. Il problema è che questi dati non sono organizzati in un modo che permetta di decidere mentre l'esercizio è ancora aperto.

1.1 Che cosa esiste oggi

Nella pratica corrente lo strumento di governo della spesa farmaceutica è, quasi ovunque, un foglio di calcolo. Funziona, ma ha limiti strutturali che ne impediscono l'uso come strumento di lavoro quotidiano di una struttura.

- ▶ Vive sul computer di una sola persona, non è condiviso né aggiornato in tempo reale dal gruppo di lavoro.
- ▶ Si aggiorna manualmente, non è collegato a un flusso vivo di acquisti e consumi.
- ▶ Non segnala nulla. Una scadenza brevettuale, un'opportunità biosimilare o uno scostamento di budget emergono solo se qualcuno va a cercarli.
- ▶ Non è replicabile. Ogni nuova Azienda richiede di ricostruirlo da zero.

1.2 Il divario che ne deriva

Gli antineoplastici e gli immunomodulatori assorbono da soli circa il 47% della spesa per acquisti diretti. Il mancato utilizzo dei biosimilari è stimato costare al sistema italiano fino a 1,7 miliardi di euro all'anno entro il 2032. La Direzione di Farmacia possiede il dato necessario ad agire su questi fronti. Ciò che manca è lo strumento che trasformi il dato in una decisione tempestiva.

La tesi del prodotto in una riga. Il valore non sta nel produrre un'informazione che non esiste, ma nel ridurre il ritardo con cui l'organizzazione reagisce a un'opportunità che esiste già.

2 I bisogni, per soggetto

Tre soggetti diversi guardano la stessa spesa farmaceutica con domande diverse. La Regione ne osserva l'andamento complessivo e i trend d'uso, la Direzione aziendale ne misura l'impatto sul proprio esercizio, la farmacia ospedaliera sa dove concretamente si perde valore. Lo strumento serve tutti e tre, ma non nello stesso modo: la tabella che segue distingue che cosa ciascuno governa o monitora, di che cosa ha effettivamente bisogno e con quale ruolo entra nel progetto.

Soggetto	Che cosa governa o monitora	Bisogno reale	Ruolo
Regione Servizio Farmaceutico	Riparto del fondo e monitoraggio della spesa delle Aziende. Indirizzi di appropriatezza. Le gare centralizzate sono in capo alle Stazioni appaltanti, cui vanno richiesti atti ed esiti	Analizzare gli scenari e i trend d'uso dei farmaci, orientare le scelte di governance farmaceutica, rispondere al Tavolo di monitoraggio, misurare la variabilità fra Aziende	Acquirente naturale
Azienda Sanitaria Direzione	Delibere di acquisto e organizzazione interna. Un budget farmaceutico dedicato non è sempre assegnato alla singola Azienda: in molti casi il compito è di monitoraggio, non di rispetto di un tetto proprio	Monitorare l'andamento della spesa mentre l'esercizio è aperto, disporre di una proiezione di fine anno affidabile, valutare e documentare le proprie scelte in sede di controllo	Co-acquirente o utente
Farmacia ospedaliera	Appropriatezza operativa, allestimento, distribuzione ai reparti. L'elenco dei prodotti disponibili non è una sua scelta: deriva dalle gare e dai contratti del Provveditorato	Sapere dove si perde valore, orientare le azioni, ridurre il tempo speso in riconciliazioni manuali, avere argomenti quantificati da portare in Commissione Terapeutica	Utente operativo

Il punto che genera più confusione. La farmacia ospedaliera è il soggetto che sa dove si perde valore ed è quello che può agire sulle segnalazioni. Non è però, quasi mai, il soggetto che dispone di un capitolo di spesa per acquistare uno strumento: la decisione di acquisto è aziendale o regionale. Ne discende una regola operativa: **la farmacia ospedaliera va coinvolta come utente e come promotore tecnico, non come cliente pagante.**

Una precisazione sul prontuario. Il documento non presuppone l'esistenza di un prontuario terapeutico regionale. Dove esiste, è un riferimento utile. Dove non esiste, il termine di confronto sono le gare aggiudicate e i contratti aziendali in essere, che è ciò che il modulo M1 utilizza per la verifica di aderenza.

3 Che cosa fa e che cosa non fa

VIS Pharma Compass fa	VIS Pharma Compass non fa
Legge i flussi economici e di consumo già prodotti dall'Ente	Non scrive su cartella clinica, gestionali o anagrafiche
Aggrega per molecola, ATC, canale, Azienda, periodo	Non elabora dati per produrre informazioni sul singolo paziente
Quantifica in euro le opportunità non colte	Non raccomanda terapie, dosaggi o sostituzioni individuali
Segnala scostamenti, scadenze e variabilità fra Aziende	Non emette alert clinici né avvisi di interazione
Produce reportistica direzionale e di supporto ai flussi	Non sostituisce il gestionale di farmacia né il sistema amministrativo e contabile dell'Ente
Traccia ogni analisi a fini di verifica	Non decide, non prescrive, non automatizza atti sanitari

3.1 Qualificazione regolatoria

Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento UE 2017/745 e della guida MDCG 2019-11, un software è dispositivo medico solo se persegue una finalità medica sul singolo paziente. VIS Pharma Compass elabora esclusivamente informazioni aggregate a fini organizzativi, gestionali ed economici e non genera informazioni cliniche nuove riferite a un individuo. La destinazione d'uso è documentata, allegata al contratto, vincolante per il fornitore e verificabile dall'Ente.

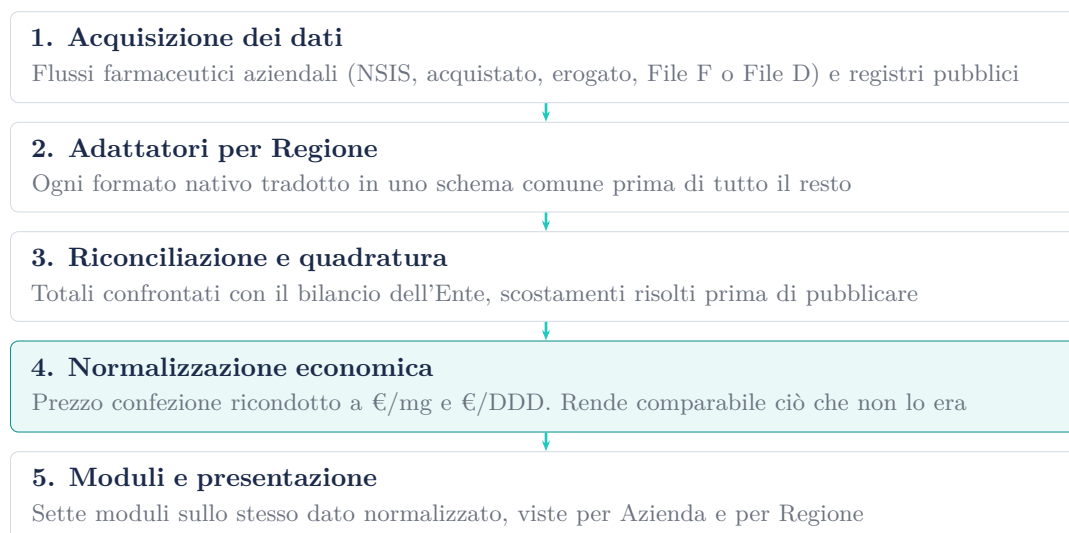
Dove passa il confine, in concreto. Lo strumento può segnalare che su una molecola l'Azienda ha 3,8 milioni di euro ancora allocati sull'originator mentre il biosimilare è disponibile. Non può dire, e non dice, che cosa fare del paziente Rossi. La valutazione di sostituibilità clinica, incluso il consiglio del farmacista al clinico, avviene fuori dallo strumento, nei canali istituzionali già esistenti quali la Commissione Terapeutica e i protocolli di interscambio approvati.

3.2 Coerenza con la legge 132/2025

Anche in quanto strumento non dispositivo, VIS Pharma Compass è progettato secondo i principi di centralità della decisione umana e di tracciabilità introdotti dagli artt. 7 e seguenti. Ogni elaborazione è ricostruibile fino al record di origine e nessuna funzione automatizza una decisione sanitaria. Le funzioni assistite da modelli linguistici, ove attivate, operano su dati aggregati, sono opzionali, disattivabili e registrate in log.

4 Come funziona: l'architettura in cinque stadi

Ogni modulo legge dall'uscita dello stadio 4, mai direttamente dai dati grezzi. È questo che tiene i moduli matematicamente coerenti fra loro.



4.1 Le fonti in ingresso

Il modulo si alimenta dei flussi farmaceutici che l'Azienda già produce: la tracciabilità del farmaco trasmessa al NSIS, il dato dell'acquistato e dell'erogato, e il flusso di rendicontazione della distribuzione diretta e per conto, denominato File F o File D a seconda della Regione. A questi si affiancano fonti pubbliche esterne.

Fonte	Che cosa fornisce	Natura
Flussi farmaceutici aziendali	Acquistato, erogato, tracciabilità NSIS, File F o File D secondo la denominazione regionale	Interna, mensile
AIFA, Liste di Trasparenza	Molecole per le quali un equivalente o un biosimilare è <i>effettivamente</i> in commercio, con il prezzo di riferimento	Pubblica
AIFA, elenco carenze	Farmaci temporaneamente carenti	Pubblica
Egualia	Associazione italiana dei produttori di farmaci equivalenti e biosimilari. Pubblica un calendario delle scadenze di esclusiva, la cui profondità di copertura è fra i punti di diligenza del capitolo 11	Pubblica
WHO ATC/DDD	Definisce la dose giornaliera usata nella normalizzazione economica	Pubblica, stabile
Anagrafica farmaci licenziata	Decomponi il codice AIC in principio attivo, dosaggio e dimensione della confezione	Esterna, a licenza
Schede di dimissione ospedaliera	Giornate di degenza e accessi diurni, che sono i denominatori di attività del modulo M8	Interna, annuale
Anagrafe della popolazione pesata	Denominatore per gli indicatori pro capite del modulo M8	Interna o regionale

4.2 Che cosa fa, in concreto, lo stadio 4

Il prezzo di una confezione non è confrontabile con quello di un'altra finché non è ricondotto al contenuto, perché la stessa molecola è commercializzata in confezioni che differiscono per numero di unità e per dosaggio. Lo stadio 4 esegue questa riconduzione e produce due unità di misura, usate per domande diverse.

- **Euro per milligrammo di principio attivo.** Prezzo diviso per il contenuto totale. Appropriato dove ciò che conta è la massa complessivamente somministrata.
- **Euro per DDD**, la dose giornaliera definita dall'OMS. È l'unità adottata da AIFA nella reportistica OsMed, e non è sostituibile con la precedente: due molecole possono essere entrambe dosate in milligrammi e richiedere quantità giornaliere molto diverse per ottenere lo stesso effetto. La DDD è ciò che rende comparabili formulazioni di potenza differente, cosa che il semplice rapporto per milligrammo non fa.

Una seconda normalizzazione, per confrontare Aziende e non confezioni. Le due unità sopra rendono confrontabili due prodotti. Non rendono confrontabili due Aziende: un ospedale che ricovera di più consuma di più e sembrerà sempre peggiore. Per il confronto fra strutture lo stadio 4 produce anche indicatori normalizzati per attività erogata, cioè DDD per 100 giornate di degenza e accessi diurni, spesa per giornata di degenza e indicatori pro capite. Sono gli stessi che AIFA utilizza nei rapporti OsMed, quindi il confronto avviene su una metrica pubblica e con la media nazionale come riferimento esterno. È ciò che alimenta il modulo M8.

Perché questo stadio è il vincolo tecnico del progetto. La riconduzione richiede di decomporre ogni codice AIC in principio attivo, dosaggio e dimensione della confezione. Una procedura automatica di decodifica risolve circa il 70% dei prodotti unici del perimetro. Il residuo, dell'ordine di 1.700 prodotti, richiede una mappatura manuale, delimitata e non ricorrente. Finché la riconduzione non è completata su tutto il perimetro, il modello adotta differenziali di prezzo convenzionali anziché quelli osservati nei dati, come indicato al capitolo 11.

4.3 Scalabilità multi Regione

Il formato di esportazione di ciascuna Regione è assorbito da un adattatore dedicato allo stadio 2. Nulla a valle di quello strato cambia da una Regione all'altra: stessi moduli, stessa matematica, stessa interfaccia. L'onboarding di una nuova Regione concentra quindi il lavoro nella costruzione e validazione del suo adattatore, non in una riprogettazione del sistema.

5 I moduli

Ogni modulo è una lente diversa sullo stesso dato riconciliato e normalizzato. Il modulo M1 è il presupposto tecnico di tutti gli altri.

Legenda dello stato di maturità. **IN ESERCIZIO** funzione dimostrabile sul prototipo con dati reali. **IN RILASCIO** funzione specificata e in fase di completamento. **IN SVILUPPO** funzione a roadmap, disponibile su richiesta di sviluppo congiunto.

#	Modulo	Che cosa fa	Stato
M1	Cruscotto direzionale della spesa	Vista unificata e riconciliata di spesa e consumi per Azienda, canale, ATC e molecola, con scostamenti in corso d'esercizio e proiezione di fine anno	IN ESERCIZIO
M2	Radar scadenze brevettuali e biosimilari	Incrocia la spesa effettiva con il calendario delle perdite di esclusiva e con la quota residua su originator, e valorizza in euro il differenziale non colto	IN ESERCIZIO
M3	Registri AIFA, File F e flussi	Riconcilia il consumo erogato con la posizione a registro e con il File F, segnala i trattamenti consumati e non registrati	IN RILASCIO
M4	Scorte, scadenze e carenze	Capitale immobilizzato, valore a rischio a 30, 60 e 90 giorni, esposizione alle carenze dichiarate, proposte di redistribuzione	IN RILASCIO
M5	Oncologia, sprechi di allestimento	Residuo di allestimento non recuperato per molecola, centro e giornata. Dove l'allestimento è già centralizzato in un laboratorio UFA, la leva non è la centralizzazione ma la concentrazione temporale delle sedute	IN RILASCIO
M6	Confronto fra Aziende	La stessa molecola e lo stesso canale confrontati fra tutte le Aziende del perimetro regionale. Disponibile solo nella titolarità regionale	IN ESERCIZIO
M7	Orizzonte e simulazione di impatto	Farmaci in arrivo sulla base delle sole fonti pubbliche: opinioni CHMP e autorizzazioni EMA, poi classificazione AIFA alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Stima dell'impatto di budget prima dell'ingresso in prontuario	IN SVILUPPO
M8	Benchmark di consumo normalizzato per attività	Indicatori OsMed calcolati sui flussi dell'Ente: DDD per 100 giornate di degenza, spesa per giornata, spesa per DDD, indicatori pro capite. Confronto fra Aziende e con la media nazionale, con scomposizione dell'eccedenza fra effetto prezzo ed effetto composizione	IN RILASCIO

Due precisazioni sui moduli, emerse dalla revisione clinica.

- **M3.** La segnalazione dei trattamenti erogati e non registrati è la funzione con il ritorno più immediato e più difficile da ottenere oggi con mezzi manuali, perché richiede di incrociare tre fonti che nessuno confronta sistematicamente.
- **M7.** Le negoziazioni AIFA non sono pubbliche e non sono osservabili prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il modulo non le include e non le stima. Lavora sulle sole fonti pubbliche a monte, cioè le opinioni CHMP e le autorizzazioni EMA, e sul dato di classificazione quando diventa ufficiale.

5.1 Funzioni trasversali e di dettaglio

Funzione	Sede	Valore	Stato
Calendario delle gare da anticipare	M2	Segnala i contratti in rinnovo a prezzo pieno pochi mesi prima della perdita di esclusiva. Errore frequente e costoso	IN RILASCIO
Benchmark dei prezzi di aggiudicazione fra Aziende	M6	Stessa molecola, stesso confezionamento, prezzi diversi fra Aziende della stessa Regione. Argomento diretto verso la centrale di committenza	IN RILASCIO
Simulazione di aggregazione della domanda	M6	Quanto varrebbe, in leva negoziale, acquistare come Regione anziché come singole Aziende	IN SVILUPPO
Alert previsionale di sfioramento del tetto	M1	Segnala con mesi di anticipo la traiettoria verso lo sfioramento, non solo quando è già avvenuto	IN RILASCIO
Aderenza al prontuario aziendale e ai contratti di gara	M1	Valorizzazione dei consumi su prodotti fuori dai contratti aggiudicati o fuori dal prontuario aziendale, per Azienda e struttura erogante. Non presuppone l'esistenza di un prontuario regionale	IN SVILUPPO
Fascicolo documentale a supporto dei controlli	M3	Raccolta ordinata e riconciliata dei dati e delle elaborazioni, con la traccia fino al record di origine. Riduce il tempo di preparazione di una risposta a una verifica. Non sostituisce l'istruttoria dell'Ente né ne garantisce l'esito	IN SVILUPPO
Indice di qualità del dato per Azienda	M3	Completezza e coerenza dei flussi trasmessi, inclusi i due elementi che condizionano gli altri moduli: se lo scarico delle confezioni sia registrato per struttura erogante e se il registro delle preparazioni sia disponibile in forma aggregata. Trasforma un prerequisito tecnico in un indicatore di performance organizzativa	IN RILASCIO
Rendicontazione ambientale dei farmaci smaltiti	M4	Valore e volume dei prodotti giunti a scadenza, utilizzabile nel bilancio di sostenibilità dell'Ente. Copre ciò che la farmacia dichiara: quanto scade nei reparti resta oggi fuori da qualunque rilevazione e il modulo non lo ricostruisce	IN SVILUPPO
Indicatore del tempo di reazione	Trasv.	Misura il tempo fra la disponibilità di un'opportunità e l'azione dell'Ente. Comprende il tempo di contrattualizzazione di un nuovo farmaco, che varia sensibilmente da Azienda ad Azienda a parità di condizioni. È il fondamento del modello di attribuzione del valore	IN ESERCIZIO
Scomposizione prezzo contro composizione	M8	Separa la quota di eccedenza dovuta al prezzo unitario pagato dentro la stessa classe terapeutica da quella dovuta a un diverso mix di prodotti. Determina se l'interlocutore è l'ufficio acquisti o la Commissione Terapeutica	IN RILASCIO
Grafico a quadranti sugli indicatori OsMed	M8	Posiziona ciascuna Azienda su consumo e costo rispetto alla media, in una lettura immediata di quale delle due dimensioni genera lo scostamento	IN RILASCIO
Report scientifico aggregato e anonimizzato	Servizio	Materiale per pubblicazioni scientifiche e per la presentazione a società scientifiche, con l'Ente fra gli autori. Valore reputazionale e chiave di accesso ai bandi	IN ESERCIZIO

5.2 Limiti invalicabili, per modulo

#	Limite dichiarato
M1	Nessuna analisi per singolo paziente. Il livello minimo di aggregazione è la struttura erogante.
M2	Identifica e quantifica l'opportunità. La valutazione di sostituibilità clinica resta interamente del farmacista e del clinico.
M3	Segnala il disallineamento. Non accede ai registri e non compila alcuna scheda in luogo dell'operatore.
M4	Propone la redistribuzione. Non emette ordini e non movimenta stock. La proposta è attendibile solo se l'Azienda registra lo scarico delle confezioni per struttura erogante: dove il movimento si ferma al magazzino centrale il modulo lavora al solo livello aggregato di Azienda.
M5	Qualsiasi funzione che calcoli, proponga o verifichi la dose per un singolo paziente ricade nella Regola 11 del Regolamento UE 2017/745 ed è esclusa dal perimetro contrattuale. Dove esiste già un laboratorio UFA centralizzato la leva della centralizzazione è esaurita, e il modulo misura il residuo e la concentrazione delle sedute.
M6	Costruibile solo a perimetro regionale. Richiede i dati di tutte le Aziende del perimetro.
M7	Lavora su numerosità attese e spesa aggregata, e sulle sole fonti pubbliche. Non identifica pazienti eleggibili e non anticipa l'esito delle negoziazioni AIFA, che non è pubblico prima della Gazzetta Ufficiale.
M8	Riporta consumo e costo normalizzati per attività, confrontati fra strutture eroganti. Non valuta l'appropriatezza della singola prescrizione, non produce raccomandazioni terapeutiche e non associa alcun indicatore a un singolo prescrittore. Le classificazioni terapeutiche sono usate come chiave di aggregazione economica, non come criterio di giudizio clinico. Richiede due flussi esterni al perimetro farmaceutico.

6 Due livelli di titolarità: Azienda e Regione

Il sistema prevede due gestori distinti, l'Azienda Sanitaria e la Regione, con perimetri di visibilità separati. Un'Azienda può acquistare lo strumento per un proprio obiettivo e usarlo autonomamente. Quando è la Regione a contrattualizzare, il perimetro si estende a tutte le Aziende incluse e si abilita la funzione di confronto.

	Modello A. Contratto regionale	Modello B. Contratti aziendali
Chi firma	La Regione o la centrale di committenza	Ciascuna Azienda separatamente
Chi accede	Ogni Azienda, con vista sui propri dati. La Regione con vista consolidata	Solo l'Azienda contraente
Confronto fra Aziende (M6)	Disponibile. È la funzione a maggiore valore	Impossibile per costruzione
Cicli di vendita	Uno	Uno per Azienda
Percorso amministrativo	Più complesso, spesso via centrale di committenza	Affidamento diretto, più semplice
Allineamento con l'incentivo	Alto	Medio

6.1 Perché il confronto fra Aziende è la funzione decisiva

Il confronto omogeneo fra Aziende della stessa Regione, sulla stessa molecola e sullo stesso canale, produce due effetti che nessun'altra funzione produce.

1. **Rende visibile la variabilità organizzativa.** Se su una molecola tre Aziende su quattro hanno convertito al biosimilare e la quarta no, la differenza non è clinica. È organizzativa, ed è documentata.
2. **Crea la pressione che rende l'azione inevitabile.** È il meccanismo che trasforma una segnalazione in una decisione. Una segnalazione interna si può rinviare, un confronto regionale documentato molto meno.

Questa funzione può essere acquistata solo dalla Regione, perché richiede i dati di tutte le Aziende. È al tempo stesso l'argomento di vendita più forte verso la Regione e la ragione per cui il modello regionale è preferibile.

La Regione non distribuisce un prodotto. Sottoscrive un contratto a perimetro e abilita accessi profilati. È lo stesso schema con cui una Regione contrattualizza una piattaforma di flussi o un sistema di sorveglianza, senza che questo comporti alcuna cessione di licenza alle Aziende.

7 A chi si rivolge

Destinatario	Moduli di interesse	Beneficio principale
Direzione Generale e Sanitaria	M1, M6, M8	Proiezione di fine esercizio affidabile, posizionamento dell'Azienda rispetto alle altre della Regione, difendibilità in sede di controllo
Direzione di Farmacia	M1, M2, M3, M4, M5	Sapere dove si perde valore e orientare le azioni di conseguenza, disporre di opportunità già quantificate in euro da portare in Commissione Terapeutica, ridurre il tempo speso in riconciliazioni manuali
Controllo di gestione	M1, M3	Riconciliazione fra consumo, flussi e bilancio, scostamenti rilevati in corso d'esercizio anziché a consuntivo, individuazione delle unità di misura errate in anagrafica e conseguente revisione del costo unitario
Ufficio acquisti e prov-veditorato	M2, M6	Calendario delle gare da anticipare, benchmark dei prezzi di aggiudicazione, leva negoziale documentata
Servizio Farmaceutico Regionale	M1, M2, M6, M7, M8	Variabilità fra Aziende resa misurabile e normalizzata per attività, confronto con la media nazionale sugli indicatori OsMed, presidio del tetto e del ripiano, programmazione dell'impatto dei farmaci in arrivo

Non serve un progetto dei Sistemi Informativi. Il funzionamento richiede soltanto la messa a disposizione periodica di estrazioni che l'Azienda già produce per altri obblighi. Non c'è scrittura sui sistemi esistenti, non c'è integrazione applicativa da progettare e non c'è dipendenza dal fornitore della cartella clinica. Le funzioni descritte in questo capitolo restano quindi in capo al Controllo di gestione, alla Direzione di Farmacia e al Servizio Farmaceutico Regionale.

7.1 Posizionamento rispetto ai sistemi esistenti

VIS Pharma Compass non compete con i sistemi informativi ospedalieri né con i gestionali di farmacia. Ne presuppone l'esistenza e ne utilizza gli output. Il valore che aggiunge è di natura diversa: la lettura economica trasversale, il confronto fra Aziende e la traduzione del dato in opportunità quantificata. Non richiede la sostituzione di alcun sistema in essere e non genera dipendenza tecnologica.

7.2 Indipendenza dai produttori

Il fornitore non riceve corrispettivi, sponsorizzazioni o finanziamenti da titolari di autorizzazione all'immissione in commercio. Poiché le analisi di switch, di appropriatezza e di confronto fra prodotti hanno effetti economici diretti sui produttori, questa condizione non è lasciata a una dichiarazione di intenti: è assunta come obbligazione contrattuale, allegata al contratto, con facoltà dell'Ente di risolvere in caso di violazione.

8 Evidenze dal prototipo su dati reali

Quanto segue è il risultato dell'applicazione del modello a un perimetro regionale reale. I valori sono riportati in forma aggregata e anonimizzata.

Dimensione	Valore rilevato
Aziende Sanitarie incluse	4
Canali distributivi	3 (consumo ospedaliero, distribuzione diretta, distribuzione per conto)
Record di erogazione elaborati	261.153
Spesa farmaceutica, esercizio di riferimento	452,7 milioni di euro
Spesa dell'esercizio precedente	435,0 milioni di euro, con incremento del 4,1%
Profondità della serie storica	3 annualità, granularità mensile
Livelli di analisi	ATC dal primo all'ultimo livello disponibile

8.1 Concentrazione della spesa

Le prime venti specialità per spesa assorbono 128,8 milioni di euro, pari al 28,5% dell'intero perimetro. Le prime venti per incremento assoluto hanno generato un aumento di 24,4 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, con casi di crescita da zero a oltre 2,5 milioni di euro in una sola annualità.

Questa concentrazione è la ragione per cui la governance selettiva funziona: **presidiare quaranta voci significa presidiare oltre un terzo della spesa.**

8.2 Esposizione alle scadenze brevettuali e quota residua su originator

Ambito	Voci	Spesa esposta	Quota
Scadenze brevettuali a 12 mesi	21	22,8 mln €	5,0%
di cui prime due specialità	2	14,2 mln €	3,1%
Prime 20 specialità per spesa	20	128,8 mln €	28,5%
Prime 20 specialità in incremento	20	+24,4 mln €	n.a.
Spesa residua su originator con biosimilare disponibile e penetrazione sotto il 50%	8	13,6 mln €	3,0%
di cui su molecole a penetrazione biosimilare pari a zero	3	8,0 mln €	1,8%

Perché questo dato conta. Nessuno di questi casi è visibile in un report di spesa tradizionale, che aggrega per ATC e non distingue originator da biosimilare all'interno della stessa molecola. Il dato regionale aggregato, allineato o superiore alla media nazionale, nasconde situazioni molecola per molecola profondamente diverse.

9 Modello economico e costi

9.1 Il principio di attribuzione

Non si sostiene che il software generi il risparmio. Il risparmio da perdita di esclusiva lo genera la scadenza brevettuale, quello da switch lo genera la decisione del clinico e del farmacista, il recupero da accordo negoziale lo genera il contratto fra AIFA e il titolare.

Ciò che uno strumento di governance può causare in modo difendibile è una cosa sola: **la riduzione del ritardo con cui l'organizzazione reagisce a un'opportunità già esistente.** Su questo, e solo su questo, è costruita la stima. La conseguenza pratica è rilevante: la misurazione del beneficio non richiede di isolare l'effetto del software da quello dell'azione professionale, esercizio metodologicamente contestabile. Richiede di misurare il tempo che intercorre fra la disponibilità dell'opportunità e l'azione dell'Ente, prima e dopo l'adozione. È un indicatore osservabile, concordabile in sede contrattuale e verificabile da un terzo.

9.2 Stima del valore su perimetro regionale

Perimetro di riferimento: quattro Aziende Sanitarie, 452,7 milioni di euro di spesa annua. La stima poggia su quattro leve distinte. Prima della tabella, ciascuna è spiegata a parole, perché è la logica a dover essere verificabile, non il numero.

Leva 1. Ingresso di un equivalente dopo la perdita di esclusiva

Sul perimetro, 22,8 milioni di euro di spesa insistono su specialità la cui esclusiva è attesa in scadenza entro dodici mesi. Da questa base si applicano quattro riduzioni successive, tutte prudenziali.

Passaggio	Fattore	Perché
Spesa esposta a scadenza entro 12 mesi	22,8 mln €	Base di partenza
Quota su cui un equivalente entra davvero in commercio	60%	Una scadenza di esclusiva non produce automaticamente un equivalente. Vedi il riquadro sotto
Quota contendibile nell'esercizio	35%	Contratti in essere, lotti già aggiudicati, pazienti in continuità
Differenziale di prezzo	20%	Ipotesi convenzionale, non un esito di gara osservato
Frazione d'anno guadagnata	90 giorni	Il beneficio è l'anticipo, non il risparmio totale
Valore della leva	240.000 €/anno	

Che cosa significa davvero una scadenza brevettuale. La perdita di esclusiva non implica che il farmaco avrà un generico o un biosimilare, e la data non è un fatto certo. Può essere spostata da certificati protettivi complementari, estensioni pediatriche e contenziosi, e in diversi casi nessun produttore ha interesse a entrare, specialmente su molecole a basso volume o con processi produttivi complessi. Per questa ragione il modello tratta la scadenza come una *finestra di attenzione* e non come una data di risparmio, e introduce il fattore del 60% sopra. La conferma che un equivalente esiste davvero arriva soltanto dalle Liste di Trasparenza AIFA, cioè quando il prodotto è già in commercio. Il modulo M2 distingue i due stati e non li somma.

Leva 2. Quota ancora allocata sull'originator dove il biosimilare è già in commercio

Qui non c'è incertezza sull'esistenza dell'alternativa: sono 13,6 milioni di euro su molecole per le quali il biosimilare è già nelle Liste di Trasparenza. Si applica una quota switchabile del 50%, che tiene conto della continuità terapeutica e dei pazienti già in trattamento, un differenziale del 25% e un'attribuzione allo strumento del 30%, perché la decisione resta del clinico e del farmacista. **Valore: 144.000 €/anno.**

Leva 3. Presidio delle molecole in forte incremento

Le prime venti specialità per incremento assoluto hanno prodotto 24,4 milioni di euro di crescita in un esercizio. Recuperarne l'1,5% attraverso la verifica di coerenza con i contratti aggiudicati e con il prontuario aziendale vale **205.000 €/anno**. È la leva meno visibile e la più continuativa: agisce su ciò che cresce, non su ciò che è già grande.

Leva 4. Recuperi da accordi negoziali non richiesti

I recuperi teorici da accordi negoziali valgono nell'ordine dell'1,1% della spesa. Assumendo che il 3% di essi non venga richiesto entro il termine utile, il valore recuperabile è di **60.000 €/anno**. È l'ordine di grandezza derivato da dati nazionali aggregati e la sua verifica sul perimetro dell'Ente è uno degli obiettivi del periodo di prova.

Leva 5. Allineamento del costo unitario fra Aziende, a parità di attività

Le quattro leve precedenti lavorano tutte su farmaci ad alto costo unitario con un equivalente disponibile o atteso. Questa lavora sul resto del prontuario, cioè sulle categorie ad alto volume e basso costo unitario dove nessuna delle precedenti ha qualcosa da dire.

Il metodo è stato verificato sulla spesa per antibiotici in assistenza ospedaliera di una Regione italiana con quattro Aziende Sanitarie, sul triennio 2023-2025. I dati sono reali, riportati in forma anonimizzata.

Indicatore, esercizio 2024	Regione	Media Italia	Scarto
DDD per 100 giornate di degenza	82,2	83,4	-1,4%
Spesa per DDD	9,26 €	7,17 €	+29%
Spesa pro capite	5,65 €	3,88 €	+46%

Il risultato che nessun report di spesa produce. La Regione non consuma più antibiotici della media italiana: a parità di attività ospedaliera è leggermente sotto. Li paga il 29% in più. È una diagnosi diversa da quella che si otterrebbe guardando la sola spesa, e porta a un’azione diversa: non un intervento sull’appropriatezza prescrittiva, ma una rinegoziazione.

Scendendo alle singole Aziende, tre su quattro stanno fra 7,36 e 7,40 euro per DDD nel 2024. La quarta sta a 14,63. Scomponendo l’eccedenza di quest’ultima per classe terapeutica, l’83% deriva dal prezzo unitario pagato dentro la stessa classe e solo il 17% da un diverso mix di prodotti. Non prescrivono molti più antibiotici di riserva degli altri, li comprano a un prezzo più alto.

Passaggio	Fattore	Perché
Divario rispetto al miglior valore già ottenuto nel perimetro, 2025	1.510.000 €	Pari al 22% della spesa della categoria
Quota contendibile nell’esercizio	35%	L’Azienda fuori linea ha la casistica più complessa: parte del divario è clinicamente legittima
Attribuzione allo strumento	30%	La rinegoziazione resta dell’ufficio acquisti
Valore della leva	159.000 €/anno	

Questa leva ha un prerequisito che le altre non hanno. Servono due flussi esterni al perimetro farmaceutico: le schede di dimissione ospedaliera, per giornate di degenza e accessi diurni, e l’anagrafe della popolazione pesata. Senza denominatori di attività il confronto fra Aziende non è normalizzabile e la leva non è calcolabile. La loro disponibilità va verificata con l’Ente prima di includere il modulo M8 in offerta.

Perché il valore è misurato e non stimato. A differenza delle leve precedenti, che applicano parametri convenzionali a una base di spesa, questo divario è stato osservato su dati reali di un perimetro esistente. Resta specifico di quel perimetro e di quella categoria: su un Ente con minore variabilità interna il valore sarà inferiore, su un perimetro con più Aziende e più categorie sarà superiore, perché il metodo si applica identico a ogni categoria terapeutica.

Riepilogo

Leva		Valore annuo
1	Ingresso di un equivalente dopo la perdita di esclusiva	240.000 €
2	Quota ancora su originator con biosimilare già in commercio	144.000 €
3	Presidio delle molecole in forte incremento	205.000 €
4	Recuperi da accordi negoziali non richiesti	60.000 €
5	Allineamento del costo unitario fra Aziende, a parità di attività	159.000 €
Totale scenario prudenziale		808.000 €
Totale scenario minimo, parametri dimezzati		404.000 €

Che cosa non è incluso nella stima. Non sono valorizzati il risparmio da riduzione dei prodotti giunti a scadenza, il minor capitale immobilizzato, il recupero del residuo di allestimento oncologico, il tempo professionale liberato dalla reportistica manuale e la riduzione del rischio di rilievo in sede di controllo. Sono benefici reali, ma si preferisce misurarli durante il periodo di verifica anziché stimarli in offerta.

9.3 Listino modulare

Il modello di prezzo è a modulo e a perimetro, non a utente. Il numero di utenti abilitati è illimitato all'interno dell'Ente contraente. Non sono previsti costi per postazione, per report generato o per volume di dati elaborato.

Modulo	Azienda singola	Quota regionale	Per Azienda del perimetro
M1 Cruscotto direzionale (propedeutico)	14.000 €	25.000 €	6.000 €
M2 Radar scadenze e biosimilari	12.000 €	20.000 €	incluso
M3 Registri, File F e flussi	10.000 €	18.000 €	incluso
M4 Scorte, scadenze e carenze	8.000 €	12.000 €	incluso
M5 Oncologia, sprechi di allestimento	8.000 €	12.000 €	incluso
M6 Confronto fra Aziende	non disponibile	15.000 €	incluso
M7 Orizzonte e simulazione di impatto	10.000 €	15.000 €	incluso
M8 Benchmark di consumo per attività	10.000 €	18.000 €	incluso
Configurazione completa	72.000 €	135.000 €	+6.000 / az.

Nella configurazione regionale il canone è dato dalla somma delle quote dei moduli attivati più una quota di 6.000 € per ciascuna Azienda inclusa nel perimetro, che copre l'accesso profilato e la vista consolidata. Attivazione una tantum: 6.000 € per Azienda singola, 15.000 € più 2.000 € per Azienda nella configurazione regionale. Importi al netto di IVA ove dovuta.

9.4 Passo zero: analisi diagnostica

Prima di qualunque contratto, l'Ente può acquistare una sola cosa: la verifica, sui propri dati, che le opportunità descritte in questo documento esistano davvero nel suo perimetro. È questo il passo zero.

Contenuto	
Che cosa fornisce l'Ente	Un'estrazione di dodici mesi dei flussi che già produce. Nessuna installazione, nessun accesso ai sistemi, nessun coinvolgimento dei Sistemi Informativi oltre l'estrazione
Che cosa riceve	Tre consegne: la quadratura dei totali con il bilancio, con gli scostamenti documentati. La lista delle opportunità individuate sul suo perimetro, ciascuna quantificata in euro. La relazione metodologica che spiega come ogni valore è stato ottenuto
Durata	Tre settimane dalla consegna dell'estrazione
Corrispettivo	9.000 €, una tantum
Che cosa non è	Non è un canone ridotto, non è una prova gratuita, non dà accesso alla piattaforma e non obbliga l'Ente a proseguire
Effetto sul prezzo successivo	Nessuno. Il canone eventuale non è scontato né aumentato in funzione di questo passaggio

La distinzione fra analisi diagnostica e canone introduttivo è deliberata. Un canone di ingresso a prezzo basso fissa un riferimento da cui ogni rinnovo appare come un aumento, ed è la principale

causa di mancato rinnovo nel settore pubblico. L'analisi diagnostica è invece una prestazione professionale autonoma, che si conclude con una consegna e non condiziona nulla di ciò che viene dopo.

Il criterio di decisione è semplice. Se la lista delle opportunità individuate sui dati reali dell'Ente non vale un multiplo evidente del canone proposto, non c'è ragione di procedere, e la conversazione si chiude con una relazione metodologica che resta comunque all'Ente.

9.5 Configurazioni tipiche e percorso amministrativo

Configurazione	Anno 1	24 mesi	36 mesi	Percorso a 24 mesi
Azienda singola M1+M2	32.000	58.000	84.000	Affidamento diretto
Azienda singola M1+M2+M3	42.000	78.000	114.000	Affidamento diretto
Azienda singola, tutti i moduli	78.000	150.000	222.000	Procedura negoziata
Regione 4 Aziende, M1+M2+M3	110.000	197.000	284.000	Procedura negoziata
Regione 4 Aziende, M1+M2+M3+M8	128.000	233.000	338.000	Procedura negoziata
Regione 4 Aziende, tutti i moduli	182.000	341.000	500.000	Procedura negoziata

La soglia di 140.000 € dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 si applica al valore complessivo dell'affidamento, non al canone annuo.

Un vincolo da conoscere prima di impostare la trattativa. Il ricorso ripetuto all'affidamento diretto verso lo stesso fornitore per la medesima prestazione, allo scopo di restare sotto la soglia dei 140.000 euro, configura frazionamento artificioso ed è vietato. La sequenza corretta è: primo affidamento autonomo e motivato, e successivo passaggio a procedura negoziata o ad accordo quadro regionale quando il perimetro si estende. Presentare in offerta il percorso amministrativo corretto è un elemento di affidabilità, non una debolezza.

9.6 Rapporto fra valore e costo

Configurazione	Canone annuo	Sc. minimo	Sc. prudenziale
Regione, 4 Aziende, M1+M2+M3	87.000 €	3,7×	7,5×
Regione, 4 Aziende, M1+M2+M3+M8	105.000 €	3,8×	7,7×
Regione, 4 Aziende, tutti i moduli	159.000 €	2,5×	5,1×
Azienda singola, M1+M2	26.000 €	da calcolare sul perimetro aziendale	

La soglia di pareggio. Perché il servizio si ripaghi è sufficiente concretizzare il 13,0% dello scenario prudenziale nella configurazione regionale che comprende il benchmark per attività. Anche realizzando un solo quinto della stima, il ritorno resta superiore al doppio del canone.

9.7 Perché non si propone il risparmio condiviso

Un fornitore che proponga a un ente pubblico di essere remunerato con una quota del risparmio generato sta proponendo, nella sanità italiana, uno schema che oggi non ha né una base contabile né un precedente documentato.

- **Il beneficiario non coincide con l'acquirente.** In un sistema a tetto e a ripiano, il risparmio farmaceutico di un'Azienda confluisce in larga parte nella posizione regionale.
- **Manca la voce contabile.** Il bilancio di un'Azienda Sanitaria non prevede una posta standard per remunerare un privato con una quota di risparmio non energetico.
- **Manca il certificatore.** Servirebbe un terzo indipendente e una linea di base concordata. È il punto più contestato anche nei contratti di rendimento energetico.
- **Manca il precedente.** Gli accordi a esito riguardano i titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, non i fornitori di servizi informativi.

Che cosa si propone al suo posto. Canone fisso, fatturazione trimestrale posticipata, nessuna revisione di prezzo in corso di contratto. Al sesto mese si verificano gli indicatori concordati in avvio: in caso di mancato raggiungimento l'Ente recede senza oneri né penali. Il ritorno economico è un argomento a supporto della decisione, non un elemento del corrispettivo. **Il rischio economico dell'operazione, per l'Ente, è limitato al canone di un semestre.**

10 Dati, sicurezza e attivazione

Ambito	Impegno
Titolarità	L'Ente resta titolare del trattamento. Il fornitore agisce come responsabile ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
Minimizzazione	Il modello funziona su dati aggregati per struttura, molecola e periodo. Ove il modulo M3 richieda un livello di dettaglio per record, la pseudonimizzazione è effettuata all'origine, a cura dell'Ente, prima della trasmissione
Localizzazione	Elaborazione e conservazione su infrastruttura qualificata situata nell'Unione Europea, con opzione di installazione presso il data center dell'Ente
Valutazione d'impatto	Il fornitore mette a disposizione la documentazione tecnica a supporto, incluse le misure di sicurezza e la descrizione delle logiche di elaborazione
Tracciabilità	Registro degli accessi e delle elaborazioni, conservato e consultabile dall'Ente
Reversibilità	A fine contratto l'Ente riceve l'intero patrimonio informativo elaborato in formato aperto e documentato, senza costi di uscita

10.1 Percorso di attivazione in novanta giorni

Fase	Contenuto
Giorni 1 a 30	Definizione del perimetro e degli indicatori di verifica. Acquisizione dei tracciati e prima estrazione. Quadratura con i dati di bilancio e con i flussi già trasmessi. Sottoscrizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento
Giorni 31 a 60	Configurazione delle anagrafiche, del prontuario e delle soglie. Validazione dei risultati con la Direzione di Farmacia. Predisposizione della documentazione a supporto della valutazione d'impatto
Giorni 61 a 90	Rilascio in esercizio, profilazione degli utenti, formazione. Consegna del primo report direzionale con la lista delle opportunità quantificate
Mese 6	Verifica congiunta degli indicatori concordati. Facoltà di recesso dell'Ente senza oneri

11 Limiti, assunzioni e condizioni di successo

Questa sezione è parte integrante del documento. Un fornitore che non dichiara i limiti del proprio strumento sta trasferendo all'acquirente un rischio non prezzato.

11.1 Limiti dello strumento

- ▶ VIS Pharma Compass non è un dispositivo medico e non può essere impiegato per finalità diagnostiche, prognostiche o terapeutiche riferite al singolo paziente. Ogni uso difforme è escluso dal perimetro contrattuale.
- ▶ La qualità degli indicatori dipende dalla qualità e dalla completezza dei flussi in ingresso. La fase di quadratura iniziale serve a misurare questo elemento e, se necessario, a ridefinire il perimetro.
- ▶ Lo strumento individua e quantifica opportunità. **Non le realizza.** Il beneficio si concretizza solo se l'organizzazione dispone della capacità decisionale e operativa per agire sulle segnalazioni.
- ▶ La quota di penetrazione biosimilare non è comprimibile a zero. Continuità terapeutica, pazienti già in trattamento e specifiche indicazioni cliniche costituiscono un limite fisiologico che il modello considera tramite il parametro di switchabilità.
- ▶ **Una scadenza di esclusiva non produce automaticamente un equivalente, e la sua data non è certa.** Certificati protettivi complementari, estensioni pediatriche e contenziosi possono spostarla, e su alcune molecole nessun produttore ha interesse a entrare. Il modulo M2 tratta la scadenza come finestra di attenzione e considera l'opportunità confermata soltanto quando l'equivalente compare nelle Liste di Trasparenza AIFA.
- ▶ Il modulo M4 richiede che l'Azienda registri lo scarico delle confezioni per struttura erogante. Dove il movimento si ferma al magazzino centrale, le proposte di redistribuzione restano al solo livello aggregato di Azienda.
- ▶ Le negoziazioni AIFA non sono osservabili prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il modulo M7 non le stima e non le anticipa.
- ▶ Il modulo M8 confronta consumo e costo normalizzati per attività erogata. Uno scostamento rispetto alla media segnala una differenza da spiegare, non un errore: parte della variabilità è casistica legittima. La distinzione fra eccedenza di prezzo ed eccedenza di composizione serve proprio a separare ciò che è organizzativo da ciò che è clinico, e la valutazione della seconda componente resta dei clinici dell'area.

11.2 Assunzioni della stima economica

- ▶ I valori del capitolo 9 derivano da un perimetro reale ma specifico. Su un perimetro diverso per dimensione, casistica o livello di partenza, i risultati saranno diversi.
- ▶ I differenziali di prezzo adottati (20% e 25% a seconda della leva) sono ipotesi prudenziali generiche e non riflettono esiti di gara specifici dell'Ente. Non è stato usato il rapporto di prezzo osservato nei dati per una ragione precisa: originator e biosimilare della stessa molecola sono quasi sempre venduti in confezioni diverse per numero di unità e per dosaggio, quindi il rapporto fra i due prezzi di listino misura anche la differenza di confezionamento e non solo la differenza di prezzo del principio attivo. Usarlo produrrebbe un differenziale gonfiato o compresso a seconda dei casi. Il differenziale convenzionale è la scelta più prudente finché la normalizzazione per milligrammo non è completata su tutto il perimetro.
- ▶ La stima relativa ai recuperi da accordi negoziali è un ordine di grandezza derivato da dati nazionali aggregati. La sua verifica sul perimetro dell'Ente è uno degli obiettivi del periodo di verifica.

11.3 Punti di diligenza tecnica ancora aperti

- ▶ **Anagrafica di riferimento.** La decomposizione del codice AIC in principio attivo, dosaggio e dimensione della confezione richiede una fonte strutturata licenziata. Le condizioni di licenza non sono ancora confermate. Una procedura automatica di decodifica estrae l'informazione per circa il 70% dei prodotti unici, il residuo è mappatura manuale delimitata, non un ostacolo.
- ▶ **Calendario delle scadenze brevettuali.** La profondità di copertura della fonte pubblica non è ancora verificata, e il calendario indica una scadenza attesa, non l'ingresso effettivo di un equivalente. Il modulo incrocia quindi il calendario con le Liste di Trasparenza AIFA, che sono l'unica fonte che certifica la disponibilità reale. È previsto un calendario commerciale come alternativa o integrazione, con costo non ancora valutato.
- ▶ **Denominatori di attività del modulo M8.** Le giornate di degenza e gli accessi diurni provengono dalle schede di dimissione ospedaliera, la popolazione pesata dall'anagrafe assistiti. Sono due flussi esterni al perimetro farmaceutico: la loro disponibilità, la profondità storica e la cadenza di aggiornamento vanno verificate con l'Ente prima di includere il modulo in offerta. Dove non sono disponibili, il modulo non è attivabile.
- ▶ **Fonti regolatorie europee del modulo M7.** La raggiungibilità e la frequenza di aggiornamento delle opinioni CHMP e delle autorizzazioni EMA in formato strutturato vanno verificate prima di impegnare il modulo in offerta. È la ragione per cui M7 è classificato in sviluppo e non è compreso nelle configurazioni di ingresso.

11.4 Condizioni di successo

- ▶ Referente unico della Direzione di Farmacia con mandato esplicito sul progetto.
- ▶ Disponibilità dei flussi con cadenza almeno mensile e profondità storica di almeno 24 mesi.
- ▶ Definizione, prima dell'avvio, degli indicatori di verifica e della linea di base.
- ▶ Inserimento delle opportunità quantificate in un momento decisionale già esistente, quale la Commissione Terapeutica o il monitoraggio periodico di budget, anziché in un flusso informativo parallelo.
- ▶ Registrazione dello scarico delle confezioni per struttura erogante e disponibilità del registro delle preparazioni in forma aggregata. Sono i due prerequisiti che determinano quanto i moduli M4 e M5 possono restituire, e sono misurati dall'indice di qualità del dato in fase di quadratura.

12 Il percorso realistico di adozione

Fase	Contenuto e obiettivo
Fase 1. Una Azienda	Contratto singolo, importo contenuto, affidamento diretto. Serve a produrre la referenza e la misura del beneficio, non il fatturato
Fase 2. La Regione	Con una Azienda già attiva e un risultato misurato, la proposta regionale ha un precedente interno. Il confronto fra Aziende diventa l'argomento principale
Fase 3. Altre Regioni	Solo con almeno due esercizi conclusi e un dato di beneficio verificato da un soggetto interno all'Ente

12.1 Prossimi passi

	Attività	Contenuto e impegno richiesto
1	Incontro di presentazione	Un'ora, con la Direzione di Farmacia e il Controllo di gestione. Presentazione del prototipo funzionante su dati reali
2	Analisi diagnostica	Su un'estrazione di dodici mesi fornita dall'Ente. Consegna entro tre settimane della lista delle opportunità individuate e valorizzate
3	Definizione del perimetro	Scelta dei moduli, della durata e degli indicatori di verifica. Emissione dell'offerta economica definitiva
4	Perfezionamento	Affidamento secondo il percorso amministrativo individuato al capitolo 9, con nomina a responsabile del trattamento e destinazione d'uso allegata
5	Attivazione	Novanta giorni al rilascio in esercizio, verifica congiunta al sesto mese

[Denominazione del Fornitore] · [Indirizzo]
 Codice fiscale e partita IVA · [PEC] · [Referente del progetto]